

五十肩で長引いている方へ

—— 病院に行っているのに変わらない、あなたへ ——

PTのる（わたなべみのる）

理学療法士・CSCS | 整形外科外来20年以上

X: @katarail_pt

■ はじめに

LINE登録、ありがとうございます。

このPDFには、3つのことを書きました。

- ①五十肩が長引くとき、何が起きているのか（3人の事例から）
- ②自分のいまの状態を整理する、3択のチェック
- ③夜の痛みで眠れないときに、今夜できること

全部読まなくて大丈夫です。いま夜がつらい方は、③だけ先にどうぞ。

その前に、ひとつだけ聞かせてください。

コンロの奥を拭こうとして、腕が届かない。

洗濯物を干すとき、ハンガーをとおす動作が地味に痛い。

服を脱ごうとして、声が出そうになる。

でも、それは全部、一人のときに起きること。家族の前では、なんとかしてしまう。

だから「肩でしょ、そのうち治るよ」と言われる。

痛みそのものより、分かってもらえないことのほうが、しんどい。

外来で20年、そういう方に何人もお会いしてきました。ひとつでも心当たりがあったら、このまま読み進めてみてください。

■ ①五十肩が長引くとき、何が起きているのか

長く悩んでいる方のお話を聞いていると、だいたい3つのパターンのどれかにいることが多いんです。

どれも「努力が足りない」のではありません。止まっている場所が、少しずつ違うだけです。

【事例A】52歳・女性・パート勤務

※実際の複数の患者さんの経過を組み合わせた架空の例です

リハビリに週2回、半年通っていた方でした。担当の先生からは「順調ですよ。可動域が広がってますね」と言われ続けていた。でも、彼女の中には、ずっと解けない問いがあった。

「先生は良くなってると言う。なのになぜ、服を着るとき今でも痛いんだろう」

数字の上では、たしかに回復している。でも、日常の困りごととは変わっていない。噛み合わないまま、彼女は「私の感覚がおかしいのかな」とまで思い始めていました。

私は、彼女の感覚のほうが正しいと思いました。

医療者が見ている「改善の物差し」と、彼女が生活の中で感じている物差しが、少しずれていただけなんです。「服を着るとき痛い」「後ろに手が届かない」——そういう具体的な動作で伝えられるようになってから、先生との会話が変わった、と彼女は言っていました。

【事例B】47歳・男性・デスクワーク

※実際の複数の患者さんの経過を組み合わせた架空の例です

整形外科でレントゲンを撮って、「骨に異常なし。様子を見ましょう」と言われた方でした。でも痛い。夜も眠れない日がある。

「骨に問題がないなら、この痛みは何なんだ」

その疑問は、もっともだと思います。

「異常なし」は「何もなし」という意味ではないんです。レントゲンで見えるのは、骨だけ。腱や滑膜の炎症は、レントゲンには映りません。だから正確に言えば「今の検査では見えなかった」であって、「体に何も起きていない」ではない。

彼は「異常なし」という言葉に引かかったまま、自分の痛みを信じられなくなっていました。「何を調べたの異常なしだったのか」が分かったとき、「ああ、痛くて当然だったんだ」と、少しほっとした顔をされていたのを覚えています。

【事例C】55歳・女性・専業主婦

※実際の複数の患者さんの経過を組み合わせた架空の例です

ストレッチの動画も見た。医師にも「自宅での運動が大事ですよ」と言われた。やるべきことは、ちゃんと分かっていた方でした。でも、親の介護が始まって、自分のことは後回しになり続けた。

「続けられない私がダメなんですよ」と、申し訳なさそうに言われました。

私は、そうは思いませんでした。

やる事が分かっている状態は、「何をすればいいか分からない状態」とは、まったく違います。条件が変わったとき、すぐに動けるのは彼女のほうです。いまできていないことと、向かう先が分かっていることは、別の話なんです。

ここで少しだけ、数字の話をさせてください。

五十肩になった方を平均4年以上追いかけた研究では、約4割の方に何らかの症状が残っていたと報告されています（Hand 2008）。「自然に治る」と言われるわりに、止まったまま時間が過ぎていく方は、それだけ多い。

だからもし、あなたがいま治っていなくても、それはあなたが特別に治りが悪いわけでも、頑張りが足りないわけでもありません。

止まっている場所が、まだ見えていないだけ——そういう方を、私はたくさん見てきました。

■ ②自分のいまの状態を整理する、3択チェック

3つの事例のうち、いまのあなたに一番近いのはどれでしょうか。どれもぴったりでなくて大丈夫です。「強いて言えば」で選んでみてください。

A 「良くなってますね」と言われる。でも、生活は変わっていない。（事例Aに近い）

→ 次の診察で「服を着るとき痛い」など、困っている動作をひとつだけ伝えてみてほしいんです。それだけで先生の返事が変わった方を、何人も見てきました。

B 「異常なし」と言われた。でも、痛い。（事例Bに近い）

→ 「何を調べての異常なしですか？（骨？腱？炎症？）」と聞いてみてください。検査の種類によって、見えているものが違います。あなたの痛みは、気のせいではありません。

C やるべきことは分かっている。でも、続けられる環境がない。（事例Cに近い）

→ 向かう先が分かっていること自体が、あなたの財産です。いまは「できない時期」なだけで、「分からない」のとは違います。ご自身を責めないであげてください。

選んだら、LINEでひとこと送ってください。

「Aで、服を着るとき」のように、選んだ記号と、いま一番困っている場面だけで大丈夫です。

私が読んで、お返事します（無料です）。ひとりで抱えているより、少し軽くなると思います。

■ ③夜の痛みで眠れないときに、今夜できること

「枕を脇の下に入れる」「抱き枕で横向きに寝る」

全部試した。でも、変わらなかった。

そういう方、本当に多いんです。あなただけではありません。そして、変わらなかったのには、ちゃんと理由があります。

枕の工夫が効くのは、「肩が硬くなって、引っ張られて痛むタイプ」の夜間痛です。

でも、夜中に何度も目が覚める、じんじんと疼く——そういう方に多いのは「肩の中に炎症があるタイプ」。

昼間は体を動かしているのだから、炎症の産物も流れていきます。夜、横になると、肩は体と同じ高さになって、炎症で腫れた組織に液がこもりやすくなる。

姿勢の問題ではなく、血流と炎症の問題なんです。だから、枕の位置を変えても変わらなかった。

そういう夜に私がお伝えしているのは、3つだけです。

- 1** 無理に横にならない。座って寝ていい。
ソファやリクライニングで、座ったまま寝てください。座れば肩は心臓より下にぶら下がって、こもった圧が重力で少しずつ抜けていきます。
- 2** 痛む肩を、反対の手でやさしくさする。
強く揉まないでください。手のひらで、ゆっくり触れるだけでいいんです。「さすっていたら、いつの間にか眠れていた」—— 外来で、何度も聞いてきた言葉です。
- 3** 今夜を乗り越えることだけ、考える。
「正しい姿勢」で寝ることより、1時間でも多く眠れることのほうが、回復にとってはよっぽど大事です。

「座って寝る」は、一生続くわけではありません。炎症が落ち着けば、横になれる夜は戻ってきます。

枕の位置を何度も直して、それでも痛くて、「やり方が悪いのかな」と自分を責めてしまう。それが、一番もったいないんです。

あなたのやり方が悪いのではなくて、アドバイスがあなたのタイプに合っていなかった。それだけのことです。

■ 相談メニュー

ひとりで整理するのがしんどいときは、頼ってください。

① LINEチャット相談（500円/回）	② Zoom相談（3,500円/30分）	③ 伴走プラン（12,000円/月）
気になることを、ひとつだけ聞きたいときに。	いまの状態と「次の一手」を、一緒に整理します。	チャット相談いつでも（原則48時間以内に返信）＋週1回の状態レビュー＋月1回のZoom相談（30分）

相談フォームはこちら →

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSferPJNbZMunEwNwWKyso63o3RuplYO6HKbgWGIFChWTH5Wrw/viewform>

※相談は、診断や治療の代わりではありません。自分の状態を言葉にして整理するための場です。受診が必要と感じたときは、はっきりお伝えします。